O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

A-6: Glaukoma, g‘ilaylik, ko‘ruv a’zosi o‘smalarida hamshiralik ishi

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Amaliy mashg‘ulot, 4 soat (160 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda glaukomada ko‘z ichi bosimini aniqlash, uning o‘zgarish xususiyatlarini baholash, glaukoma xurujini tanish va shoshilinch yordamda ishtirok etish, g‘ilaylik va ko‘z o‘smalarida parvarish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Glaukomada ko‘z ichi bosimini aniqlash va kuzatish
2. Glaukoma xuruji: belgilari, shoshilinch yordam, operatsiyaga tayyorlash
3. G‘ilaylik va ko‘z o‘smalarida amaliy parvarish

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Glaukoma sabablari, turlari, belgilari va davosini aytib beradi.
- Ko‘z ichi bosimini palpator aniqlaydi, Maklakov tonometriyasiga jihozlarni tayyorlaydi.
- Glaukoma xuruji belgilarini taniydi va yordam algoritmini bajaradi.
- G‘ilaylikda okklyuziya va ko‘z o‘smalarida parvarish qoidalarini biladi.

Tayanch so‘zlar

tonometriya, Maklakov tonometri, palpator usul, kunlik tonometriya, glaukoma xuruji, pilokarpin, iridektomiya, okklyuziya, enukleatsiya, ko‘z protezi.

1. Glaukomada ko‘z ichi bosimini aniqlash va kuzatish

Ko‘z ichi bosimini o‘lchash glaukomani aniqlash va davolash samarasini baholashning asosiy usuli. Hamshira bemorni tayyorlaydi, jihozlarni sterillaydi, shifokor rahbarligida tonometriyani bajaradi va natijani hujjatga kiritadi. Bosimni taxminiy, ya’ni palpator usulda aniqlash mumkin, ammo aniq raqam faqat tonometr yordamida olinadi. Glaukoma bilan og‘rigan bemorlarda bosim dispanser jadvali bo‘yicha muntazam tekshiriladi.

Ko‘z ichi bosimini palpator aniqlash

Jihozlar: qo‘l gigiyenasi vositalari

1. Qo‘lni yuving, bemorga muolajani tushuntiring.
2. Bemorga pastga qarashni, ko‘zni yummasdan turishni ayting.
3. Ikki ko‘rsatkich barmog‘ingizni yuqori qovoq ustiga, tog‘ay ustidagi sohaga qo‘ying.
4. Barmoqlar bilan navbatma-navbat, yengil bosib, ko‘z qattiqligini his qiling.
5. Ikkinchi ko‘zni shu tarzda tekshirib, solishtiring.
6. Natijani yozing: Tn – norma; T+1, T+2, T+3 – oshgan; T–1, T–2, T–3 – pasaygan.

Palpator usul ko‘z olmasi shikastlarida bajarilmaydi, chunki bosim to‘qimalarga zarar yetkazishi mumkin. Operatsiyadan keyingi dastlabki kunlarda ham ko‘z bosilmaydi.

Maklakov bo‘yicha tonometriya

Jihozlar: Maklakov tonometri (10 g), kollargol-glitserin bo‘yog‘i, anestetik tomchi, spirtli tampon, namlangan qog‘oz, chizg‘ich, antiseptik tomchi

1. Bemorga muolajani tushuntiring, allergiya va shox parda kasalligi bor-yo‘qligini so‘rang.
2. Bemorni chalqancha yotqizing.
3. Ikkala ko‘zga anestetik tomchi tomizing, 1–2 daqiqa kuting.
4. Tonometr maydonchasini spirt bilan arting va quriting, unga bo‘yoqni yupqa, bir tekis surting.
5. Bemorga peshonasi tepasiga qo‘yilgan barmog‘iga qarashni ayting.
6. Qovoqlarni ochib, bosim bermasdan ushlang.
7. Tonometrni shox parda markaziga vertikal, sekin qo‘ying va shu zahoti ko‘taring.
8. Maydonchadagi izni namlangan qog‘ozga bosib oling.
9. Izning diametrini chizg‘ich bilan o‘lchab, bosimni jadvaldan aniqlang.
10. Ko‘zga antiseptik tomchi tomizing, ko‘zni ishqalamaslikni ayting.

Natijalarni baholash

Tonometrik bosim normasi 18–26 mm simob ustuni. Ikki ko‘z farqi 5 mm dan oshsa, shifokorga xabar beriladi. Qon bosimi, charchash, tomchilar qabul qilish vaqti natijaga ta’sir qiladi, shu sababli takroriy o‘lchashlar imkon qadar bir

vaqtda o‘tkaziladi. Noto‘g‘ri bo‘yoq surtish, tonometrni qiyshiq qo‘yish, ko‘z yumilib qolishi xato natija beradi.

Kunlik tonometriya

Glaukomada bosim kun davomida o‘zgarib turadi. Kunlik tonometriya bu bosimni bir necha kun davomida ertalab uyg‘ongandan keyin va kechqurun bir xil vaqtda o‘lchashdir. Normada kunlik farq 5 mm dan oshmaydi. Farqning kattaligi kasallik faolligini ko‘rsatadi. Ertalabki bosim o‘rin-ko‘rpadan turmasdan, kechki bosim esa kechqurun soat 18–20 da o‘lchanadi. Hamshira natijalarni grafik yoki jadval shaklida yozadi va shifokorga taqdim etadi.

Sana	OD ertalab	OD kechqurun	OS ertalab	OS kechqurun
1-kun	24	22	27	24
2-kun	25	23	28	25
3-kun	24	22	27	23

Dispanser nazorati

Glaukoma tashxisi qo‘yilgan bemor dispanser hisobiga olinadi. Unga dispanser varaqasi to‘ldiriladi, kuzatuv muddatlari belgilanadi. Hamshira har tashrifda ko‘rish o‘tkirligini, bosimni tekshirishni, ko‘ruv maydoni tekshiruviga yuborishni tashkil etadi. Tomchilarni to‘g‘ri tomizishni tekshiradi: ko‘pincha bemor dorini noto‘g‘ri yoki tartibsiz ishlatgani uchun kasallik rivojlanadi. Bemor tomchilar yon ta’sirlarini ham bilishi kerak: masalan, timolol yurak urishini sekinlashtiradi va bronxial astmada ehtiyotkorlik talab qiladi.

2. Glaukoma xuruji: belgilari, shoshilinch yordam, operatsiyaga tayyorlash

Glaukoma xuruji har qanday kasalxona bo‘limida va poliklinikada uchrashi mumkin, chunki bemor kuchli bosh og‘rig‘i va qusish bilan terapevt yoki jarrohga murojaat qiladi. Shu sababli har bir hamshira xuruj belgilarini bilishi va shoshilinch yordamda qatnashishi shart. Xuruj vaqtida qancha tez yordam ko‘rsatilsa, ko‘rishni saqlab qolish imkoniyati shuncha yuqori bo‘ladi.

Belgi	Glaukoma xuruji	O‘tkir kon’yunktivit	O‘tkir iridotsiklit
Og‘riq	Juda kuchli, boshga tarqaladi	Achishish	O‘rtacha, kechasi kuchli
Ko‘ngil aynishi	Bor, qusish	Yo‘q	Yo‘q
Ko‘rish	Keskin pasaygan	Normal	Pasaygan
Qorachiq	Keng, oval	Normal	Tor
Shox parda	Xira, shishgan	Tiniq	Presipitatlar
Ko‘z qattiqligi	Toshdek qattiq	Normal	Normal yoki yumshoq

Glaukoma xurujida hamshira harakatlari

Jihozlar: 1% pilokarpin, pipetka, tampon, tonometr, buyurilgan dorilar, qon bosimini o‘lchash asbobi

1. Bemorni tinchlantiring, yotqizing, xonani yoriting.
2. Darhol shifokorni chaqiring yoki tez yordam chaqiring.
3. Ko‘rish o‘tkirligi va qon bosimini aniqlang, ko‘zni palpator tekshiring.
4. Ko‘rsatma bilan birinchi soatda har 15 daqiqada 1% pilokarpin tomizing, keyingi 2 soatda har 30 daqiqada, so‘ng har soatda.
5. Ko‘rsatma bilan diuretik (asetazolamid) va og‘riqsizlantiruvchi bering.
6. Oyoq vannasi kabi chalg‘ituvchi muolajani tayyorlang.
7. Hech qachon atropin yoki boshqa midriatik tomizmang.
8. Bemorni zudlik bilan ko‘z bo‘limiga kuzatib boring, bajarilgan ishlarni qayd eting.

Xurujning oldini olish

Bemorga xurujga olib keluvchi holatlar tushuntiriladi: kuchli hayajonlanish, qorong‘i xonada ko‘p o‘tirish, kino va televizorni chiroqsiz ko‘rish, uzoq vaqt bosh egib ishlash, sovqotish, ko‘p suyuqlik ichish, qorachiqni kengaytiruvchi dorilar. Bemorda doimo pilokarpin tomchisi bo‘lishi, kuchli og‘riq paydo bo‘lganda tomizib, zudlik bilan shifoxonaga murojaat qilishi kerak. Ikkinchi ko‘zda ham profilaktik choralar shifokor tomonidan belgilanadi, chunki xuruj ikkinchi ko‘zda ham rivojlanishi mumkin.

Lazer va operatsiyaga tayyorlash

Tomchilar bilan bosim nazorat qilinmasa, lazer yoki jarrohlik bajariladi. Lazer iridotomiya yoki iridektomiyada rangdor pardada suyuqlik o‘tishi uchun teshik hosil qilinadi. Trabekulektomiyada ko‘z ichi suyuqligi uchun yangi chiqish yo‘li yaratiladi. Hamshira bemorni umumiy qoidalar bo‘yicha tayyorlaydi: tahlillar, infeksiya o‘choqlarini davolash, qon bosimi nazorati, operatsiya kuni ko‘rsatma bilan tomchilar. Bemorga operatsiya yo‘qolgan ko‘rishni qaytarmasligi, faqat bor ko‘rishni saqlab qolishini aniq tushuntirish kerak, shunda u noto‘g‘ri umid bilan ruhiy tushkunlikka tushmaydi.

Operatsiyadan keyin bemor ko‘zga bosim berilishidan saqlanadi, og‘ir yuk ko‘tarmaydi. Tomchilar buyurilgan tartibda tomiziladi, operatsiya qilingan ko‘zga ba’zan glaukoma tomchilari kerak bo‘lmay qoladi, lekin bu faqat shifokor qaroriga bog‘liq. Hamshira bosim, og‘riq va ko‘rishni kuzatadi. Bemor uyga chiqarilgach, dispanser nazoratida davom etadi, chunki glaukoma davolangani bilan kasallik to‘liq yo‘qolmaydi, umrbod kuzatuvni talab qiladi.

Bemorga muloqot

Glaukomali bemorlarning ko‘pchiligi keksa yoshda. Ular tomchilarni unutishi yoki noto‘g‘ri tomizishi mumkin. Hamshira oddiy tilda tushuntiradi, jadval yozib beradi, telefondagi eslatmalardan foydalanishni maslahat beradi. Yaqinlari ham

jalb qilinadi. Koʻrish maydoni torayganda bemor yoʻlda toʻsiqlarni sezmasligi mumkin, shuning uchun xavfsizlik qoidalari alohida tushuntiriladi.

3. Gʻilaylik va koʻz oʻsmalarida amaliy parvarish

Gʻilaylik va ambliopiya davolash uzoq vaqt talab qiladi. Natija ota-onalar va hamshira hamkorligiga bogʻliq. Hamshira bolalarni profilaktik koʻrikda tekshiradi, gʻilaylikni oddiy sinamalar bilan aniqlaydi va oftalmologga yoʻnaltiradi.

Gʻilaylikni aniqlash: yopish sinamasi

Jihozlar: koʻz toʻsigʻi, kichik predmet yoki chiroqcha

1. Bolani qarshingizga oʻtqazing, u uzoqdagi predmetga qaraydi.
2. Yorugʻlik refleksi ikki qorachiqda simmetrikligini kuzating.
3. Bir koʻzni toʻsiq bilan yoping va ochiq koʻzning harakatini kuzating.
4. Ochiq koʻz oʻrnatish harakati qilsa, u ogʻib turgan boʻladi.
5. Toʻsiqni olganda yopilgan koʻz harakatini ham kuzating.
6. Ikkinchi koʻzda takrorlang va natijani yozing.

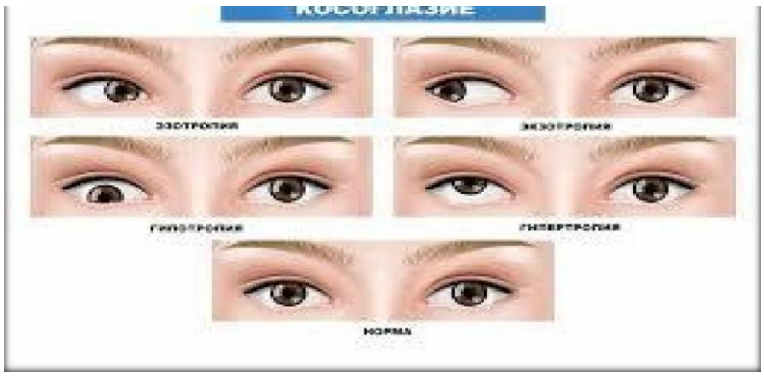
Okklyuziya

Okklyuziya ambliopiyani davolashning asosiy usuli. Yaxshi koʻradigan koʻz belgilangan vaqtga yopiladi va past koʻradigan koʻz ishga tushiriladi. Yopishtiriladigan maxsus bogʻlam yoki koʻzoynak koʻzoynagi ustiga qoʻyiladigan toʻsiq ishlatiladi. Hamshira ota-onaga bogʻlamni teriga toza va quruq holatda yopishtirishni, kuniga necha soat taqishni, teri qizarishi kuzatilsa, nima qilishni oʻrgatadi. Bola bogʻlam bilan oʻqish, chizish, oʻyin kabi yaqin masofali mashgʻulotlar bajarishi foydali. Koʻzoynak bogʻlam bilan birga doimiy taqiladi. Muntazam ravishda koʻrish oʻtkirligi tekshiriladi, chunki yaxshi koʻzda koʻrish pasayib ketmasligi kerak.

Yopishtiriladigan okklyuzion bogʻlam qoʻyish

Jihozlar: okklyuzion bogʻlam, salfetka

1. Qoʻlni yuving, ota-onaga maqsadini tushuntiring.
2. Teri toza va quruq ekanini tekshiring.
3. Bogʻlamni ochib, yaxshi koʻradigan koʻzni toʻliq yopib yopishtiring: qovoqlar erkin yumiladi.
4. Bogʻlam orqali koʻrilmayotganiga ishonch hosil qiling.
5. Bogʻlamni belgilangan vaqtdan keyin yengil namlab, sekin oling.
6. Teri holatini tekshiring va belgilab boring.



G‘ilaylik turlari: ko‘z og‘ish yo‘nalishlari

G‘ilaylik operatsiyasida parvarish

Operatsiyadan oldin bola va ota-onasi tayyorlanadi, tahlillar va umumiy og‘riqsizlantirish uchun och qoringa tayyorlash qoidalari bajariladi. Operatsiyadan keyin ko‘z qizarishi va yengil og‘riq kuzatilishi tabiiy. Tomchilar buyuriladi, bola ko‘zini ishqalamasligi nazorat qilinadi. Operatsiya ko‘zning holatini to‘g‘rilaydi, ammo binokulyar ko‘rishni tiklash uchun mashqlar va ko‘zoynak davom ettiriladi.

Ko‘z o‘smalarida parvarish

O‘smaga shubha bo‘lgan bemor ruhan og‘ir holatda bo‘ladi. Hamshira unga xushmuomala bo‘ladi, tashxis haqida faqat shifokor ma’lumot beradi. Bemor tekshiruvlarga (ultratovush, KT yoki MRT, biopsiya) tayyorlanadi. Nur terapiyasi bemorlarida ko‘z atrofi terisi va kon’yunktiva holati kuzatiladi. Kimyoterapiyada ko‘ngil aynishi, qon ko‘rsatkichlari va infeksiya xavfi nazorat qilinadi. Bolalarda retinoblastomada ota-onalarga irsiyat ehtimoli va qarindoshlarni tekshirish zarurligi tushuntiriladi.

Ko‘z protezini parvarish qilish (bemorni o‘rgatish)

Jihozlar: ko‘z protezi, qaynatilgan iliq suv yoki fiziologik eritma, steril tampon, antiseptik tomchi

1. Qo‘lni yaxshilab yuving.
2. Pastki qovoqni tortib, protezni pastga siljiting va oling.
3. Protezni iliq qaynatilgan suv yoki eritmada yuving, spirt ishlatmang.
4. Kon’yunktiva bo‘shlig‘ini buyurilgan eritma bilan tozalang va tomchi tomizing.
5. Protezni belgilangan tomon bilan yuqori qovoq ostiga kiriting.
6. Pastki qovoqni tortib, protez to‘g‘ri joylashganini tekshiring.

Enukleatsiyadan keyin bemor odatda 1–2 oydan so‘ng protez oladi. Dastlabki davrda vaqtinchalik protez ishlatilishi mumkin. Protez har bir necha yilda almashtiriladi, chiqib qolsa, toza joyda saqlanadi. Hamshira ruhiy qo‘llab-quvvatlash, jamiyatga qaytish va ishga moslashishda yordam ko‘rsatadi. Bir ko‘zli bemorga ikkinchi ko‘zni shikastdan himoya qilish, muntazam ko‘rikdan o‘tish tushuntiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.
3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.